



Forward Care Review

FCR-002

Broń przy poszkodowanym funkcjonariuszu

Komentarz ratowniczo-prawny do sytuacji przedszpitalnej

Minimum ingerencji. Maksimum bezpieczeństwa.

Komentarz edukacyjny z perspektywy ratownictwa przedszpitalnego.

Nie zastępuje procedur dysponenta, decyzji służb ani indywidualnej opinii prawnej.

Autor: Karol Huzarski, ratownik medyczny / instruktor CLS (Combat Lifesaver)

Stop Krwotokom | H-CORE Edu

Ł DOWODOV

WECZYR:

PODPIS:

MD-2024-0007

Forward Care Review No. 2

Broń służbowa przy poszkodowanym funkcjonariuszu

Komentarz ratowniczo-prawny do sytuacji przedszpitalnej

Charakter materiału

Komentarz edukacyjny z perspektywy ratownictwa przedszpitalnego. Materiał nie zastępuje procedur dysponenta ZRM, decyzji służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo miejsca zdarzenia ani indywidualnej opinii prawnej.

Podczas jednej z ostatnich konferencji i rozmów szkoleniowych pojawiło się pytanie, które dobrze pokazuje różnicę między modelem omawianym na sali wykładowej a realnością działań przedszpitalnych: co powinien zrobić zespół ratownictwa medycznego, jeżeli przy ciężko rannym funkcjonariuszu znajduje się niezabezpieczona broń służbowa?

Nie jest to problem wyłącznie akademicki. Taka sytuacja może wystąpić przy wypadku radiowozu, interwencji policyjnej, postrzeleniu, zdarzeniu masowym albo każdym innym zdarzeniu, w którym funkcjonariusz traci przytomność, a jego broń pozostaje w zasięgu osób postronnych.

Jako praktyk ratownictwa medycznego i instruktor CLS (Combat Lifesaver), przyjmuję prosty punkt wyjścia: ratownik nie jest od przejmowania broni. Ratownik jest od ratowania życia. Jednocześnie ratowanie życia nie odbywa się w próżni. Jeżeli na scenie leży broń, do której mogą podejść gapię, dzieci, agresor albo przypadkowy świadek, mamy nie tylko pacjenta, ale też realne zagrożenie dla otoczenia.



Ryc. 1. Ujęcie ilustracyjne: czasowe odizolowanie broni od osób postronnych przy zachowaniu priorytetu ewakuacji pacjenta.

1. Granica bezpieczeństwa sceny

Pierwsze zastrzeżenie musi paść od razu: jeżeli broń jest w ręku osoby przytomnej, pobudzonej, z ograniczonym kontaktem logicznym, agresywnej albo nie można wykluczyć aktywnego zagrożenia, ZRM nie powinien wchodzić w strefę bez zabezpieczenia przez właściwe służby. Bezpieczna scena jest warunkiem udzielania pomocy.

Dalszej analizy wymaga dopiero inny scenariusz: funkcjonariuszka jest nieprzytomna albo traci przytomność, broń została wcześniej odłożona lub wypadła w toku zdarzenia, a stan pacjentki wymaga natychmiastowej ewakuacji do SOR. Na miejscu nie ma innego funkcjonariusza, który może tę broń przejąć, a w pobliżu znajdują się osoby postronne.

Klucz operacyjny

Nie chodzi o wykonywanie czynności policyjnych. Chodzi o to, aby w sytuacji wyjątkowej nie pozostawić łatwo dostępnej broni w przestrzeni publicznej, gdy zespół musi odjechać z pacjentką z masywnym krwotokiem.

2. Opis przypadku

Zespół ratownictwa medycznego zostaje zadysponowany do poszkodowanej policjantki. Pacjentka ma masywny krwotok z kończyny dolnej. Wymaga natychmiastowej kontroli krwawienia, założenia opaski uciskowej lub zastosowania innej skutecznej metody tamowania krwotoku, szybkiej ewakuacji i transportu do szpitalnego oddziału ratunkowego.

Przy pacjentce leży broń służbowa. Nie ma na miejscu drugiego policjanta ani innej osoby uprawnionej, która mogłaby ją przejąć. W rejonie zdarzenia pojawiają się świadkowie. Dla ZRM powstaje konflikt praktyczny: z jednej strony priorytetem jest krwotok i transport, z drugiej - odjazd z miejsca zdarzenia może pozostawić broń w zasięgu osób postronnych.

W mojej ocenie właściwym modelem działania jest tu zasada: minimum ingerencji, maksimum bezpieczeństwa. Ratownik nie przejmuje broni dla siebie, nie rozładowuje jej, nie sprawdza magazynka i nie prowadzi czynności procesowych. Może jednak - jeżeli nie ma innego realnego rozwiązania - czasowo odizolować broń od dostępu osób postronnych, równolegle informując dyspozytora medycznego i Policję.

3. Schemat działania

- Ocena bezpieczeństwa sceny: jeżeli zagrożenie jest aktywne - nie wchodzić bez zabezpieczenia przez służby.
- Kontrola krwotoku i przygotowanie pacjentki do pilnego transportu.
- Informacja do dyspozytora: przy pacjentce znajduje się niezabezpieczona broń służbowa.
- Żądanie pilnego skierowania patrolu Policji na miejsce albo bezpośrednio do SOR.
- Jeżeli nie ma alternatywy - czasowe odizolowanie broni od osób postronnych, bez manipulowania przy mechanizmach.
- Odnotowanie faktu w dokumentacji i niezwłoczne przekazanie broni Policji.

Przykładowy komunikat do dyspozytora

Transportujemy poszkodowaną funkcjonariuszkę Policji z masywnym krwotokiem do SOR. Przy pacjentce znajdowała się niezabezpieczona broń służbowa, dostępna dla osób postronnych. Broń została czasowo odizolowana wyłącznie w celu ograniczenia bezpośredniego zagrożenia. Prosimy o pilne skierowanie patrolu do SOR celem jej przejęcia.

4. Kontekst prawny

Najważniejszym punktem odniesienia jest art. 26 Kodeksu karnego, czyli stan wyższej konieczności. Przepis ten odnosi się do działania podejmowanego w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego dobru chronionemu prawem, jeżeli niebezpieczeństwa nie można inaczej uniknąć. W omawianym scenariuszu dobrem ratowanym jest życie i zdrowie pacjentki oraz bezpieczeństwo osób postronnych.

Szczególnie istotny jest również art. 26 § 5 KK, który przewiduje odpowiednie stosowanie zasad stanu wyższej konieczności w razie kolizji obowiązków. W praktyce ratownik może znaleźć się między obowiązkiem pilnej ewakuacji pacjentki a koniecznością niedopuszczenia do pozostawienia broni w zasięgu osób postronnych.

Znaczenie ma też art. 160 KK, czyli narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Nie należy tego przepisu przedstawiać jako automatycznej podstawy odpowiedzialności, ale jako kontekst ryzyka. Jeżeli broń leży w miejscu publicznym i jest realnie dostępna, całkowite zignorowanie zagrożenia może być trudne do obrony z perspektywy bezpieczeństwa sceny.

Jednocześnie trzeba pamiętać o art. 263 KK, który penalizuje posiadanie broni palnej bez wymaganego zezwolenia. Dlatego ewentualne działanie ratownika musi być wyjątkowe, krótkotrwałe, proporcjonalne, jawnie zgłoszone dyspozytorowi i Policji oraz ukierunkowane wyłącznie na izolację zagrożenia, a nie na dysponowanie bronią.

Dodatkowo art. 5 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym wskazuje, że osoba wchodząca w skład ZRM podczas wykonywania zadań korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. Przepis ten wzmacnia kontekst działania ratownika jako osoby wykonującej zadania ratownicze, ale nie tworzy uprawnień policyjnych do broni.

5. Granice: czego ratownik nie powinien robić

W szkoleniu trzeba wyraźnie oddzielić czasowe odizolowanie zagrożenia od obsługi broni. Ratownik nie powinien: rozładowywać broni, sprawdzać komory naboju, wyjmować magazynka, manipulować bezpiecznikiem, wkładać broni do kieszeni, przekazywać jej osobie nieuprawnionej ani przewozić jej bez poinformowania dyspozytora i Policji.

Najbezpieczniejsze szkoleniowo sformułowanie brzmi: ratownik nie przejmuje broni. Ratownik czasowo izoluje bezpośrednie zagrożenie, jeżeli nie ma innej realnej możliwości zabezpieczenia życia i zdrowia ludzi.

6. Pięć zasad minimalnego zabezpieczenia broni

1	Nie dotykaj broni, jeżeli nie musisz Jeżeli na miejscu jest Policja, Żandarmeria Wojskowa albo inna uprawniona służba - broń zabezpieczają oni.
2	Traktuj każdą broń jak załadowaną Nie sprawdzaj, nie rozładowuj, nie manipuluj zamkiem, magazynkiem ani bezpiecznikiem.
3	Nie chwytaj za spust ani za okolice języka spustowego Palec i dłoń pozostają poza kabłąkiem. Chwyt ma minimalizować ryzyko przypadkowego strzału.
4	Nie kieruj lufy w stronę ludzi Jeżeli broń musi zostać przemieszczona, lufa ma być skierowana w możliwie najbezpieczniejszym kierunku.
5	Użyj rękawiczek i ogranicz kontakt do minimum Rękawiczki chronią przed kontaktem z materiałem biologicznym oraz ograniczają ryzyko zatarcia śladów na broni. Następnie broń należy niezwłocznie przekazać Policji.

Najkrócej do zapamiętania

Nie obsługuję. Nie rozładowuję. Nie wkładam palca na spust. Nie kieruję lufy w ludzi. Izoluję zagrożenie i przekazuję Policji.

7. Wniosek praktyczny

W omawianym scenariuszu pozostawienie broni służbowej ciężko rannej policjantki na ulicy, przy osobach postronnych, podczas gdy ZRM odjeżdża z pacjentką w stanie bezpośredniego zagrożenia życia, byłoby rozwiązaniem trudnym do zaakceptowania operacyjnie. Ratownik powinien przede wszystkim ratować pacjentkę, ale równocześnie nie może ignorować oczywistego zagrożenia dla otoczenia.

Najbardziej racjonalne działanie to: zabezpieczyć pacjentkę, czasowo odizolować zagrożenie, poinformować dyspozytora i Policję, wykonać pilny transport do SOR i niezwłocznie przekazać broń właściwym funkcjonariuszom.

Nie jest to działanie zamiast Policji. Jest to działanie ratownicze w warunkach przymusu sytuacyjnego.

Wnioski końcowe

W ratownictwie przedszpitalnym nie wszystko mieści się w prostych schematach konferencyjnych. Czasami decyzja nie wynika wprost z gotowego algorytmu, ale jest konieczna, aby nie dopuścić do większego zagrożenia. W przypadku ciężko ranego funkcjonariusza i niezabezpieczonej broni służbowej najważniejsze pozostają trzy zasady: bezpieczeństwo sceny, priorytet ratowania życia i natychmiastowe przekazanie odpowiedzialności właściwym służbom.

Bibliografia - stan prawny na 17.06.2026

1. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 383 z późn. zm., art. 26, art. 160, art. 263.
2. Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 141, art. 5.
3. Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 485 z późn. zm.
4. Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 244 - pomocniczo w kontekście broni służbowej funkcjonariuszy.

Autor: Karol Huzarski - ratownik medyczny, instruktor CLS (Combat Lifesaver)
Stop Krwotokom | H-CORE Edu
FCR-002 | Forward Care Review

